

诊所小游戏

按E看灯。看的时候读数越来越不对，但是Sa没发现，玩家发现了。然后椅子本身就是个躺椅。大概是灯看到进度条结束了，然后Ulises把灯撤走了。结果天花板上的pattern太像软墙给Sa干出闪回了。

1. 准备仪器：玩家亲手把笼子接上

保留你旧版的【打开柜子】【接上移动电池】，这个特别好。

但它的叙事含义可以更明确：

玩家不是“找道具”，而是亲手恢复一个医疗装置的供电。这个装置本来是帮他的，但从Sa的身体记忆里，它也和束缚、评估、稳定、审查是一类东西。

低成本做法就是两个普通交互点：

- 柜子：拿出移动电池 / 备用诊断模块
- 仪器侧面：接入电池

然后房间里某个旧屏幕亮起来，不需要弹复杂UI。屏幕上只出现很短的 in-world 字：

AUXPUMP / NEURAL RESPONSE CHECK
VISUAL FIXATION REQUIRED
PATIENT MOVEMENT: MINIMIZE

这里的英文/Y2K医疗UI可以很有味道，不需要功能复杂。

2. 坐下：从TPS切fixed cam

这一步非常适合你现有框架。

玩家互动诊疗椅后，Sa躺下，镜头锁到固定角度。

不要再允许自由走动。

这不是“过场”，是进入一个轻微受控状态。

Ulises可以还在旁边正常说话，但重点不是对话，而是身体配置：

- 电极贴上
- 椅背后仰
- 诊疗灯落下来

- 屏幕亮度变高
- Sa手指搭在扶手上
- 可能有一根松的固定带，不扣死，但视觉上像会扣死

我会避免真的让Ulises粗暴束缚他。更恐怖的是：这只是正常诊疗，但Sa的身体把它读成另一件事。

2. 按E看灯

提示：

按住 E：看灯

越简单越好。不要“保持稳定”“不要动”一开始就来。

Sa本人对这个检查没有很大警惕，玩家也觉得只是普通校准。

进度条推进。Ulises正常给指令。

Sa也正常嘴碎。

3. 玩家看到读数越来越不对

这里读数是给玩家看的，不是给Sa看的。

Sa盯着灯，看不到/不看仪器屏幕。或者他看了也不懂/不在意。

读数可以从很医疗的正常项慢慢滑：

```
FIXATION OK
AUXPUMP SYNC OK
NEURAL NOISE: 12%
NEURAL NOISE: 31%
RESPONSE LAG
MEMORY TRACE CONTAMINATION?
DO NOT INTERRUPT
```

但不要让它变成红色大警报。

最好是冷静地变坏。

4. 进度条完成

这一步很重要。

检查不是失败，是完成。

进度条到100%。
仪器“叮”一声。
Ulises说好了。
他把灯撤走。

玩家和Sa都会本能松一口气。

5. 灯撤走，露出天花板 pattern

然后真正的触发物出现。

不是灯。
不是仪器。
不是Ulises。
是灯后面的天花板。

天花板上可能有：

- 旧隔音泡棉格纹
- 某种重复菱形/圆角矩形 pattern
- 维护舱板的软缝

它不是精神病院软墙。
但太像了。

这一下非常恐怖，因为它完全无辜。
Ulises也没做错。
设备也没做错。
Sa刚刚还通过了检查。
可他一看到天花板，那套空间记忆直接盖下来。

灯撤走前：画面大部分是白灯。
灯撤走后：白灯离开画面，天花板 pattern 填满画面。

停半秒。

没有音乐。
只有AuxPump一下重音。

然后 pattern 轻微变形，不需要大特效。
缝隙变厚。
白色变成软墙那种脏白。

远处传来很低的门锁声/鞋底声。

Ulises在旁边说话，但声音被房间吸掉。

Sa的呼吸突然断一下。

这时候才开始闪回。

闪回不要做完整地图，做“白色物件替换”

你旧方案的“白色诊室→白色软墙房”非常省，也很对。

不要切到大精神病院地图。只需要几个近景替换：

- 电极贴片 → 束带扣环
- 诊疗灯 → 观察灯
- Ulises的手套 → 护工手套残影
- 椅背皮革 → 软墙材质
- 仪器滴声 → 门锁/脚步/远处广播
- 光点 → 观察窗反光

这个段落应该像Sa眼睛没闭，但现实材质开始换皮。

玩家看到的不是“回忆关卡”，而是诊所被他的身体重写了一秒。